

# La fórmula que no llega

Cuando la falla no distingue entre pobres y ricos

**Daniel A. Garavito Jiménez**

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

Son las 4:40 de la tarde de un martes. En el mostrador de una droguería de cualquier ciudad del país, una mujer entrega una fórmula con cuatro medicamentos y recibe dos. Le dicen que vuelva. Vuelve. En la base de datos del sistema quedó registrada una dispensación: la de los dos que sí salieron. Los otros dos no dejaron rastro.

Esa asimetría es el punto de partida de esta columna. **La entrega incompleta no produce un registro ausente: produce un registro parcial.** El sistema anota lo que entregó y no anota lo que faltó. Para saber cuánto falta hay que preguntarle a quien se quedó esperando, y el único instrumento del país que le pregunta a esa persona es una encuesta de hogares.

## El dato

En 2025, el **46,9 %** de las personas a quienes un médico les formuló medicamentos no recibió todo lo formulado. El intervalo de confianza del 95 % va de 43,6 % a 50,2 %. Entre 2012 y 2024, trece rondas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, ese indicador nunca había superado el 38,4 %.

Frente al nivel prepandémico —el promedio de 2018 y 2019, que es 34,7 %— el salto es de **12,2 puntos porcentuales**. Frente a 2024, de 11,9. Ambas diferencias son grandes en relación con su propia incertidumbre, y en un momento explico exactamente qué significa eso.

El 11 de mayo de 2026 el Ministerio de Salud expidió la Circular Externa 017, que obliga a las EPS a entregar en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, en el domicilio o el lugar de trabajo del afiliado, los medicamentos que no pudieron entregarse completos en el punto de dispensación. Invoca el artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012, que ya obligaba a la «entrega completa e inmediata».

Una norma así fija un estándar. No fija una línea de base. La cifra de arriba es esa línea de base.

## Conviene aclarar de dónde sale el número

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida es el instrumento con el que el DANE le pregunta cada año a los hogares colombianos cómo viven. En 2025 entrevistó a **235.350 personas**. Tiene un capítulo de salud que pregunta, entre otras cosas, si el médico le formuló medicamentos y si se los entregaron todos, solo algunos o ninguno.

Tres precisiones antes de seguir, porque sin ellas el porcentaje no significa nada.

**Primera: el denominador.** El 46,9 % no es el 46,9 % del país. Es el 46,9 % *de las personas a quienes un médico les formuló medicamentos*. Un porcentaje sin denominador es un adorno. En 2025 ese denominador tiene 3.621 observaciones.

**Segunda: contra qué se compara.** Comparar 2025 con 2023 haría ver un desplome, porque 2023 todavía estaba en el piso al que bajó el sistema durante la pandemia. El punto de referencia correcto es el promedio de 2018 y 2019: los dos únicos años anteriores a la pandemia que comparten el diseño muestral vigente. Es la misma convención que usa el DANE cuando ancla sus comparaciones en «2019, año previo a la pandemia».

**Tercera: qué es el error estándar.** Una encuesta no es un censo. Estima. El error estándar mide cuánto podría moverse la estimación si se repitiera el ejercicio con otra muestra del mismo tamaño. Si una diferencia es de 12,2 puntos y su error estándar es de 1,8, la diferencia es casi siete veces su propia incertidumbre: no es ruido. Si otra diferencia fuera de 5,2 puntos con un error estándar de 8,4, la incertidumbre se comería la diferencia entera, y lo honesto sería decir que **no se distingue de cero** — que no es lo mismo que decir que es cero. Guarde esa distinción, porque el argumento de esta columna se juega ahí.

## El hallazgo no es el nivel. Es que la falla no discrimina

Todo indicador de acceso a la salud tiene gradiente. Es la regularidad más sólida de la literatura y la que organiza casi toda la política de focalización: a los hogares pobres les va peor, y a los rurales peor todavía.

En la misma encuesta y el mismo año, la necesidad de atención no satisfecha —la proporción de quienes tuvieron un problema de salud y no recibieron atención— llega al 41,0 % en el quintil más pobre y al 21,4 % en el más rico. Casi veinte puntos de diferencia. Y llega al 49,1 % en centro poblado y rural disperso frente al 32,6 % en cabecera. Dieciséis puntos y medio.

La entrega de medicamentos no tiene nada de eso.

Quintil más pobre: 50,7 %. Quintil más rico: 45,5 %. Diferencia: 5,2 puntos, con un error estándar de 8,4. No se distingue de cero. Cabecera: 47,0 %. Centro poblado y rural: 46,1 %. Tampoco. Mujeres y hombres: 47,0 % y 46,7 %. Tampoco. Quienes se reconocen en un grupo étnico y quienes no: 46,89 % y 46,88 %.

Y aquí hay que ser preciso, porque «no se distingue de cero» no es «es cero». Con 3.621 observaciones en el denominador, el intervalo de esa brecha entre quintiles va de -11,3 a +21,8 puntos: la encuesta descarta un gradiente **grande**, no uno moderado. Para detectar con confianza razonable una diferencia entre el quintil más pobre y el más rico, esa diferencia tendría que rondar los veinticuatro puntos. La afirmación defendible, entonces, es la acotada: **si hay gradiente, es mucho más pequeño que el de cualquier otra barrera de acceso de esta misma encuesta** —donde llega a veinte puntos— y esa comparación sí se sostiene.

Hay una forma resumida de decir lo mismo. El **índice de concentración** mide en qué extremo de la distribución de ingreso se acumula un fenómeno: negativo si se concentra en los pobres, positivo si se

concentra en los ricos, cero si está repartido parejo. Para la necesidad de atención no satisfecha vale -0,178 en 2025, el valor más negativo de las trece rondas. Para la entrega incompleta de medicamentos vale -0,027. Prácticamente cero, y ha oscilado alrededor de cero los trece años.

De ahí se sigue lo que a mi juicio es el hallazgo de esta serie de datos, y no es el 46,9 %.

## Por qué importa que no discrimine

Las barreras que se concentran en los pobres —el costo, la distancia, el desánimo— operan del lado de la demanda y dependen de la capacidad del hogar para sortearlas. Quien tiene plata paga el transporte. Quien tiene tiempo insiste con la autorización. Quien tiene información sabe a quién reclamarle. Por eso esas barreras tienen gradiente: la capacidad de saltarlas está desigualmente repartida.

Que la entrega incompleta no muestre un gradiente detectable —ni por ingreso, ni por zona, ni por sexo, ni por pertenencia étnica— quiere decir que el hogar **no puede sortearla en el momento del mostrador**. La falla está aguas arriba del usuario: en la compra, la contratación y el pago entre asegurador, gestor farmacéutico y dispensador. No es una falla de acceso al servicio. Es una falla de disponibilidad del insumo.

La distinción no es semántica. El artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 enumera los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, y el primero de todos es la **disponibilidad**: que los servicios y las tecnologías existan. La accesibilidad viene después. Un país puede tener resuelta la segunda y estar fallando en la primera, y eso es exactamente lo que este número describe.

La consecuencia práctica es incómoda para el diseño de política: **una falla que no discrimina no se corrige focalizando**. Un programa dirigido a los quintiles bajos deja fuera la mitad del problema.

## Seamos honestos: el dato tiene límites, y son cuatro

**Es autorreporte.** Mide lo que la persona recuerda y declara. Recordar una entrega incompleta es más probable que recordar una completa, y ese sesgo empuja el nivel hacia arriba. Ahora bien: para explicar un salto de doce puntos en un año haría falta un cambio en la forma de recordar, no un sesgo constante.

**No distingue entrega parcial de entrega nula.** Una fórmula de cinco medicamentos con cuatro entregados cuenta igual que una con cero. El indicador mide la frecuencia de la falla, no su severidad.

**No dice si el medicamento se consiguió después.** La encuesta no pregunta si la persona volvió, si se lo entregaron días más tarde o si terminó comprándolo. Por eso mismo la Circular 017, que regula precisamente la entrega diferida, no puede evaluarse todavía con este indicador. Falta una pregunta.

**El error estándar solo recoge el error de muestreo.** No mide el error de cobertura, ni el sesgo de no respuesta, ni el error de medición del autorreporte. Un intervalo estrecho es una afirmación sobre la muestra, no un certificado de verdad.

## Lo que este dato no contradice

En noviembre de 2025 la Defensoría del Pueblo publicó *Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados*, y encontró que una de cada cuatro tutelas que acompañó estaba relacionada con negación de medicamentos, y que entre el 36 % y el 37 % de esas acciones se referían a entrega tardía o incompleta. Son proporciones mucho más altas que el 46,9 % aplicado a la población general, y no se contradicen con él.

Miden universos distintos. La Defensoría ve a quien llegó hasta ella; la encuesta ve a quien recibió una fórmula. Quien tutela es quien no logró resolver por otra vía. **La distancia entre las dos cifras no es un desacuerdo: es la medida del filtro.** Y ese filtro es información valiosa por sí misma.

## Cuatro cosas que se siguen de aquí

1. **La Circular 017 ya tiene línea de base.** Es 46,9 %, con intervalo de 43,6 a 50,2. La ronda de 2026 de la encuesta, levantada después de su expedición, dará la primera medición posterior comparable. Sin punto de partida no hay evaluación posible, y ese punto de partida existe desde antes de la norma.
2. **Focalizar por pobreza no va a funcionar en este frente.** La intervención pertinente es sobre la cadena de abastecimiento y el flujo de recursos, no sobre la identificación del beneficiario.
3. **Falta una pregunta en el cuestionario.** Tres ítems —si el medicamento faltante se entregó después, en cuánto tiempo, y si la persona terminó comprándolo— convertirían un indicador de diagnóstico en un indicador de cumplimiento de la norma vigente. Es una recomendación concreta y barata al DANE.
4. **Falta publicar el módulo de diseño de todos los años.** El DANE publica el estrato y el conglomerado de la muestra solo para 2022, 2024 y 2025. Sin ese módulo, cualquiera que quiera reproducir estos errores estándar debe recurrir a una aproximación. Publicarlo para toda la serie no cuesta nada y mejora la calidad del debate.

## El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy no trabajo en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Escribo desde afuera, sin nada que defender aquí, y por eso mismo invito a contrastar cada cifra de esta columna con fuentes independientes. Los microdatos de la encuesta son públicos y el procesamiento es reproducible: el 46,9 % se puede verificar, y ojalá alguien lo haga.

Colombia resolvió el problema del carnet. La afiliación llegó en 2025 a su máximo histórico, 97,2 %, y lo hizo con una brecha por ingreso de solo dos puntos —96,9 % contra 98,9 %, una diferencia que sí se detecta pero que es de otro orden que la de cualquier otro indicador social del país— y con una afiliación algo mayor en el campo que en la ciudad. Es un logro real de treinta años de política deliberada y ningún diagnóstico honesto debería omitirlo.

Pero el carnet se universalizó mientras el servicio se deterioraba. **Tener derecho al medicamento es hoy casi universal; recibirlo completo, cada vez menos.**

Y hay algo que conviene no perder de vista en medio de la discusión sobre quién tiene la culpa: esta falla no le pregunta a nadie cuánto gana. **Las barreras del sistema colombiano casi siempre escogen a quién golpear. Esta no escoge.**

## Referencias

- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículo 6. Diario Oficial 49.427.
- Defensoría del Pueblo. (2025, 5 de noviembre). *Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados*. Bogotá.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504-515.
- Korn, E. L., & Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193-201.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2026, 11 de mayo). *Circular Externa 017 de 2026*. Bogotá.
- Presidencia de la República. (2012). *Decreto Ley 019 de 2012*, artículo 131. Diario Oficial 48.308.

## Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en [www.adres.gov.co](http://www.adres.gov.co).

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.